O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI
SHAHRISABZ ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI

MA’RUZA MATNI

“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli

N-8: Ko‘ruv a’zosining shikastlarida tez tibbiy yordam ko‘rsatish va hamshiralik parvarishi. Oftalmologik ekspertiza

Ko‘rsatkich	Ma’lumot
Mutaxassislik kodi va nomi	50910203 – Hamshiralik ishi
Kvalifikatsiya	Umumiy amaliyot hamshirasi
Mashg‘ulot turi va soati	Nazariy mashg‘ulot, 2 soat (80 daqiqa)
Ta’lim tili	O‘zbek tili
Muallif	Axmedova Roxila – Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi

Mashg‘ulot maqsadi

O‘quvchilarda ko‘ruv a’zosi shikastlarining sabablari, turlari, tez tibbiy yordam ko‘rsatish, asoratlari, hamshiralik parvarishi hamda oftalmologik ekspertiza to‘g‘risida bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish.

Reja

1. Ko‘ruv organi shikastlari: sabablari, turlari va shoshilinch yordam
2. Ko‘ruv a’zosi shikastlarining asoratlari va hamshiralik parvarishi
3. Oftalmologik ekspertiza

O‘qitish natijalari (o‘quvchi mashg‘ulot yakunida):

- Ko‘ruv organi shikastlarining sabablari va davosini aytib beradi.
- Kontuziya, yaralanish va kuyishlarda birinchi yordam tartibini tushuntiradi.
- Shikastlarning asoratlarini sanab beradi va ta’riflaydi.
- Oftalmologik ekspertiza va nogironlik guruhlarini aytib beradi.

Tayanch so‘zlar

kontuziya, yaralanish, yot jism, kuyish, kimyoviy kuyish, gifema, simpatik oftalmiya, sideroz, xalkoz, oftalmologik ekspertiza, nogironlik.

1. Ko‘ruv organi shikastlari: sabablari, turlari va shoshilinch yordam

Ko‘ruv a’zosi patologiyasining taxminan 20 foizini shikastlar tashkil etadi. Shikastlar ishlab chiqarishda, qishloq xo‘jaligida, uy sharoitida, bolalarda, sportda va harbiy holatlarda uchraydi. Ko‘rishning keyingi taqdiri ko‘p jihatdan ko‘rsatilgan birinchi yordamning sifati va tezligiga bog‘liq. Shuning uchun har bir hamshira ko‘z shikastlarini bilishi, to‘g‘ri va tez yordam ko‘rsata olishi kerak. Ko‘z mexanik, kimyoviy, termik va nur ta’sirida shikastlanadi. Joylashuviga ko‘ra ko‘z olmasi, yordamchi apparat va ko‘z kosasi shikastlari farqlanadi.

Har bir shikastlanishda sabab sinchiklab aniqlanadi: qachon, qayerda, nima bilan shikastlangan, yordam ko‘rsatilganmi, ko‘rish pasayganmi. Ko‘rish o‘tkirligi albatta tekshiriladi. Jadval bo‘lmasa, taxminiy tekshiruv o‘tkaziladi: bemor sog‘lom, keyin shikastlangan ko‘z bilan uzoqqa qaraydi yoki kitob o‘qiydi. Tibbiy hujjat to‘liq yoziladi, chunki u keyinchalik ekspertiza va huquqiy masalalarda muhim.

Kontuziya

Kontuziya to‘mtoq shikastlanish bo‘lib, to‘qimalar butunligi buzilmaydi. U qovoq, kon’yunktiva, ko‘z yoshi yo‘llari, ko‘z kosasi va ko‘z olmasida bo‘lishi mumkin. Uch darajasi farqlanadi.

Daraja	Belgilar	Yordam
Yengil	Ko‘rish pasaymaydi; teri ostiga va kon’yunktivaga qon quyilishi, shox parda eroziyasi	Birinchi soatda sovuq, tomchilar; poliklinikada davolanadi
O‘rta	Ko‘rish biroz pasayadi; qorachiq kengayishi, oldingi kameraga qon quyilishi (gifema), Fossius halqasi, to‘r parda shishi	Sovuq, 0,1% adrenalin, antiseptik tomchi, binokulyar bog‘lam, statsionarga
Og‘ir	Ko‘rish keskin pasayadi; to‘r parda yirtilishi va ko‘chishi, gemoftalm, gavhar siljishi	Antiseptik tomchi, binokulyar bog‘lam, tinchlantiruvchi, zudlik bilan ko‘z bo‘limiga

Erta gematoma shikast kuni yoki ertasiga paydo bo‘ladi. Kechki gematoma, ya’ni “ko‘zoynak belgisi” 2–3 kundan keyin yuzaga kelsa, bosh suyagi asosi singanligidan darak beradi va bemor neyroxirurgga yo‘naltiriladi. Shox parda eroziyasida kuchli og‘riq, ko‘z yoshlanishi va yorug‘likdan qo‘rqish bo‘ladi, nuqson flyuoressein bilan ko‘rinadi. Shikast kuni muzli xaltacha qo‘yiladi, keyingi kunlarda sovuq qo‘llanilmaydi.

Yaralanish

Yaralanishning asosiy farqi to‘qimalar butunligining buzilishidir. Ko‘z olmasi yaralanishi og‘ir shikast bo‘lib, teshib o‘tgan va o‘tmagan, yot jismli va yot jismsiz bo‘ladi. Absolyut belgilar: yara ko‘rinib turishi, tashqariga qon oqishi, ko‘z ichida

yot jism, rangdor pardada teshik, ichki pardalarning tushib chiqishi. Nisbiy belgilar: ko‘z ichi bosimining pasayishi va oldingi kamera chuqurligining o‘zgarishi.

Ko‘z olmasi yaralanishida shoshilinch yordam

Jihozlar: anestetik tomchi, antiseptik eritma va tomchilar, steril bog‘lam, buyurilgan in’yeksiyalar

1. Bemorni tinchlantiring, yotqizing, ko‘zga bosim bermang.
2. Yuzaki yot jism bo‘lsa, nam paxta bilan oling; yarada turgan yot jismni olmang.
3. Anestetik tomchi tomizing, antiseptik tomchi tomizing.
4. Ko‘zga binokulyar steril bog‘lam qo‘ying.
5. Ko‘rsatma bilan og‘riqsizlantiruvchi, qon to‘xtatuvchi, antibiotik va qoqsholga qarshi zardob yuboring.
6. Bemorni yotgan holatda zudlik bilan ko‘z bo‘limiga yetkazing.

Kuyishlar

Kuyishlar termik, kimyoviy va nurli bo‘ladi. Ishqorlar (ohak, kaustik soda, ammiak) kollikvatsion nekroz chaqiradi va chuqur kirib boradi, shuning uchun ular kislotalardan xavfliroq. Kislotalar koagulyatsion nekrozga olib keladi va chuqurlashmaydi. Kuyish to‘rt darajaga bo‘linadi: I daraja – qizarish, shish va eroziya; II daraja – pufaklar, kon’yunktiva oqarishi, shox parda yuzaki xiralanishi; III daraja – nekroz o‘choqlari, shox parda “xira shisha”dek; IV daraja – to‘liq nekroz, shox parda “chinni”dek oq.

Kimyoviy kuyishda birinchi daqiqalar hal qiluvchi: ko‘z darhol, ko‘p miqdorda oqar suv yoki eritma bilan 20–30 daqiqa yuviladi. Yuvishni boshqa muolajalar uchun kechiktirib bo‘lmaydi.

Kimyoviy kuyishda birinchi yordam

Jihozlar: toza suv yoki fiziologik eritma, anestetik tomchi, tampon, antiseptik tomchi, malham, bog‘lam

1. Darhol ko‘zni ko‘p miqdorda suv bilan yuvishni boshlang.
2. Qovoqlarni kengaytirib, yuqori qovoqni ag‘daring.
3. Kimyoviy modda qoldig‘ini nam paxta bilan oling.
4. Yuvishni 20–30 daqiqa davom ettiring.
5. Anestetik va antiseptik tomchi tomizing.
6. Qovoq orqasiga malham qo‘ying, bog‘lam qo‘ying.
7. Ko‘rsatma bilan og‘riqsizlantiruvchi bering, zudlik bilan bo‘limga yuboring.

Nurli kuyish, jumladan payvandlash yoki qorda quyosh nuridan elektrooftalmiya, 4–8 soatdan keyin kuchli og‘riq, yosh oqishi va yorug‘likdan qo‘rqish bilan namoyon bo‘ladi. Anestetik va namlovchi tomchilar, qorong‘i xona yordam beradi. Himoya ko‘zoynagi va niqob uning oldini oladi.

2. Ko‘ruv a’zosi shikastlarining asoratlari va hamshiralik parvarishi

Shikastning asoratlari erta va kech davrda yuzaga kelishi mumkin. Ular ko‘rishning pasayishiga, ko‘zning yo‘qotilishiga va hatto sog‘lom ko‘zning zararlanishiga olib keladi. Shuning uchun bemor shikastdan keyin uzoq kuzatiladi. Erta asoratlarga yaraning yiringlashi, yiringli iridotsiklit, endoftalmit va panoftalmit kiradi. Endoftalmitda ko‘z ichida yiring to‘planadi, panoftalmitda esa yallig‘lanish ko‘zning barcha pardalariga tarqaladi. Kuchli og‘riq, ko‘rish yo‘qolishi, qovoq shishi va harorat ko‘tarilishi kuzatiladi. Kech asoratlarga travmatik katarakta, ikkilamchi glaukoma, to‘r parda ko‘chishi, shox parda belmosi, g‘ilaylik va ko‘z olmasi atrofiyasi kiradi.

Ko‘z ichida qolgan yot jism

Ko‘z ichida yot jism qolib ketsa, u oksidlanadi va ko‘z to‘qimalarini zaharlaydi. Yot jismni aniqlash uchun rentgen tekshiruvi o‘tkaziladi: Komberg–Baltin protezi ko‘zga taqiladi va ko‘z kosasi rasmi olinadi. Ultratovush va KT ham qo‘llaniladi. Temir yot jism sideroz keltirib chiqaradi: rangdor parda zangsimon tusga kiradi, gavharda jigarrang dog‘lar paydo bo‘ladi, toksik retinopatiya rivojlanadi va ko‘ruv nervi zararlanadi. Mis yot jism xalkozga olib keladi: gavharda kungaboqar guliga o‘xshash xiralanish xarakterli. Shu sababli yot jism imkon qadar erta olib tashlanadi.

Simpatik oftalmiya

Simpatik oftalmiya eng og‘ir asoratlardan biri bo‘lib, shikastlanmagan sog‘lom ko‘zning surunkali yallig‘lanishidir. Agar yarador ko‘zda og‘ir iridotsiklit davom etsa va u tez-tez qaytalansa, yallig‘lanish ikkinchi ko‘zga o‘tishi mumkin. Kasallik shikastdan kamida 2 hafta o‘tgach boshlanadi, adabiyotlarda 1–2 va hatto 10–20 yildan keyin boshlangan holatlar ham keltirilgan. Sog‘lom ko‘zda plastik iridotsiklit yoki neyroretinit rivojlanib, ko‘rlikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun yaralanishni sifatli davolash zarur. Agar operatsiyadan keyin shikastlangan ko‘zning ahvoli yomonlashib borsa va u ko‘rmasa, sog‘lom ko‘zni saqlash uchun shikastlangan ko‘z olib tashlanadi. Hamshira bemorga sog‘lom ko‘zda qizarish, og‘riq yoki ko‘rish pasayishi paydo bo‘lsa, zudlik bilan murojaat qilishni uqtiradi.

Operatsiyadan oldingi parvarish

Hamshira ma’lumot to‘playdi: shikast mexanizmi, vaqti, ko‘rish darajasi, umumiy holat, qoqsholga qarshi emlash. Asorat xavfini baholaydi, bemorni va yaqinlarini qo‘llab-quvvatlaydi. Ko‘rishi yomonlashgan bemorning kundalik faoliyatdagi qiyinchiliklari aniqlanadi: ovqatlanish, yurish, gigiyena. Tahlillar va tekshiruvlar tezkor tashkil etiladi. Ko‘z yuvilmaydi va bosilmaydi, agar teshib o‘tgan yara bo‘lsa. Bemor ovqat yemagan bo‘lishi kerak, chunki umumiy og‘riqsizlantirish rejalashtirilishi mumkin.

Operatsiyadan keyingi parvarish

- Bog‘lamni nazorat qilish, antibiotik va yallig‘lanishga qarshi tomchilarni aniq tomizish.
- Tana harorati, og‘riq, ko‘rish, ko‘z ichi bosimini kuzatish.
- Yiringlash belgilari haqida darhol shifokorga xabar berish.
- Og‘ir yuk ko‘tarish, engashishni taqiqlash, ko‘zni ishqalamaslik.
- Ruhiy qo‘llab-quvvatlash: ko‘rishni yo‘qotish qo‘rquvi bilan ishlash.
- Bemorni ishga qaytish yoki kasbini o‘zgartirishga tayyorlash.

Shikastlarning oldini olish

Sanoat korxonalarida xavfsizlik texnikasiga rioya qilish, himoya ko‘zoynagi va niqoblardan foydalanish, ish joyini yoritish va tozalash, ishchilarni muntazam ko‘rikdan o‘tkazish muhim. Qishloq xo‘jaligida o‘rim-yig‘im vaqtida ko‘zni himoyalash zarur. Bolalar orasida tushuntirish ishlari olib boriladi: o‘tkir buyumlar, pirotexnika, kamon va otishga oid xavfli o‘yinlar taqiqlanadi, kimyoviy moddalar bolalar yetmaydigan joyda saqlanadi. Hamshira ota-onalar va maktab o‘quvchilari bilan shu mavzuda suhbatlar o‘tkazadi.

Shikastlangan bemorni hamshira kuzatuv varag‘i bo‘yicha nazorat qiladi: har kuni ko‘rish, harorat, og‘riq va ajralma xarakteri yoziladi. Har qanday yomonlashuv darhol shifokorga ma’lum qilinadi.

Bemor uyga chiqarilgach ham uzoq muddat kuzatiladi, chunki asoratlar yillar o‘tib yuzaga kelishi mumkin.

3. Oftalmologik ekspertiza

Oftalmologik ekspertiza ko‘rish faoliyati va uning patologik o‘zgarishlarini baholash orqali insonning mehnat qobiliyati, kasbga yaroqliligi, nogironlik darajasi va huquqiy masalalarini aniqlashga xizmat qiladi. Ekspertiza turlari: mehnat ekspertizasi, harbiy ekspertiza, kasbiy tanlov va sud-tibbiy ekspertiza. Hamshira ekspertiza uchun hujjatlarni tayyorlaydi, ko‘rish funksiyalarini tekshirishda ishtirok etadi va natijalarni aniq qayd etadi.

Mehnatga layoqatni aniqlash

Ko‘z kasalliklari va shikastlarida vaqtincha mehnatga layoqatsizlik kasallik varaqasi bilan rasmiylashtiriladi. Bemorning ko‘rishi va kasbi hisobga olinadi. Agar ko‘rish doimiy pasaygan bo‘lsa, bemor tibbiy-mehnat ekspert komissiyasiga yuboriladi. Ekspert komissiyasi okulist yuborgan hujjatlar asosida nogironlik guruhini, qayta tekshirish muddatini va reabilitatsiya imkoniyatlarini belgilaydi.

Guruh	Ko‘rish holati (manba bo‘yicha)	Mehnat imkoniyati
I guruh	Ikki ko‘zi ojiz yoki ko‘rish 0; bir ko‘z 0, ikkinchisida korreksiya bilan ko‘rish 0,03 dan past va ko‘ruv maydoni	O‘zgalar yordamiga muhtoj; maxsus sharoitda ishlashi mumkin

	5–10° gacha	
II guruh	Yaxshi ko‘zda korreksiya bilan ko‘rish 0,04–0,08, ko‘ruv maydoni 15–20°	Ko‘rishi past shaxslar uchun maxsus sharoit
III guruh	Bir ko‘z butunlay ojiz, ikkinchisining ko‘rishi ancha pasaygan yoki ko‘ruv maydoni keskin toraygan; ishlab chiqarish va xizmat shikasti	Kasbni o‘zgartirish, yengil ish

Nogironlik guruhlari mezonlari qonunchilik hujjatlari bilan belgilanadi va o‘zgarishi mumkin. Amaliyotda amaldagi me’yoriy hujjat bo‘yicha tekshirib ishlatiladi.

Kasbga tanlash va harbiy ekspertiza

Ayrim kasblar yuqori ko‘rish talab qiladi. Haydovchilar, uchuvchilar, temir yo‘l va dengiz xodimlari, jarrohlar, elektr payvandchilari uchun ko‘rish o‘tkirligi, rang ko‘rish, ko‘ruv maydoni va binokulyar ko‘rish tekshiriladi. Daltonizm haydovchi va uchuvchi kasblari uchun cheklov bo‘lishi mumkin. Harbiy xizmatga chaqiriqda ko‘rish va refraksiya maxsus jadvallar bo‘yicha baholanadi. Hamshira maktab bitiruvchilariga kasb tanlashda ko‘rishni hisobga olish zarurligini tushuntiradi.

Sud-tibbiy ekspertiza va simulyatsiya

Shikast olgan bemorlarda tibbiy hujjat dalil hisoblanadi, shuning uchun u aniq yozilishi kerak: shikast vaqti, mexanizmi, ko‘rish o‘tkirligi, ko‘rik natijalari va ko‘rsatilgan yordam. Ba’zan shaxs moddiy manfaat yoki xizmatdan ozod bo‘lish uchun ko‘rishi pastligini da’vo qiladi (simulyatsiya) yoki kasallikni bo‘rttiradi (aggravatsiya). Uni aniqlash uchun obyektiv usullar qo‘llaniladi: qorachiq reaksiyasi, optokinetik nistagm, skiaskopiya, elektrofiziologik tekshiruvlar. Hamshira bemorga hurmat bilan munosabatda bo‘ladi, o‘zi xulosa chiqarmaydi va faqat aniq kuzatuvlarni qayd etadi.

Reabilitatsiya

Ekspertizaning maqsadi faqat guruh belgilash emas, balki bemorni hayotga qaytarishdir. Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchilar uchun Brayl alifbosi, ovozli qurilmalar, kattalashtiruvchi lupalar, maxsus kompyuter dasturlari, mehnat korxonalari mavjud. Ko‘zi ojizlar jamiyati ishga joylashishda yordam beradi. Hamshira bemorga mavjud imkoniyatlar haqida ma’lumot beradi, ijtimoiy xodim bilan hamkorlik qiladi, oila a’zolarini yordam ko‘rsatishga o‘rgatadi.

Ekspertizada yoshga va kasbga bog‘liq talablar ham hisobga olinadi. Masalan, transport haydovchilarida ko‘rish o‘tkirligi, ko‘ruv maydoni va rang ko‘rish davriy tibbiy ko‘rikda tekshiriladi. Hamshira natijalarni rasmiylashtirishda ishtirok etadi va ko‘rish talabga javob bermagan shaxsni shifokorga yo‘naltiradi.

Ekspertiza hujjatlarida qayd etilgan raqamlar va sanalar aniq bo‘lishi kerak, chunki ular bemor huquqlariga bevosita ta’sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuldasheva F. S., Yusupova M. S., Aripova S. M. Ko‘z kasalliklari. – Toshkent: Cho‘lpon nomidagi NMIU, 2007.
2. Po‘latova Sh. A., Aripova G. S., Mirzajonova G. X. va boshq. Kattalarda hamshiralik parvarishi. II qism. – Toshkent, 2012.
3. Bikbov M. M. va boshq. Oftalmologiya: darslik (rus tilida). – Moskva: GEOTAR-Media, 2019.
4. World Health Organization. World report on vision. – Geneva: WHO, 2019.